

EXCELÊNCIA CLÍNICA & RESPONSABILIDADE GLOBAL

O USO RACIONAL DOS ANTIBIÓTICOS NA ODONTOLOGIA



Uma Análise Multidisciplinar para a Prática Premium.



SUMÁRIO EXECUTIVO

- I. A Gênese e o Paradigma Atual
- II. Terapêutica vs. Profilaxia: O Eixo da Decisão
- III. Endocardite e o Protocolo Cardíaco
- IV. Matriz de Populações Específicas
- V. O Padrão-Ouro de Prescrição
- VI. A Controvérsia Cirúrgica
- VII. A Pandemia Silenciosa da Resistência
- VIII. Governança e Controle
- IX. Síntese Evidenciária na Estética

A CIÊNCIA COMO ARTE

Em 1928, a descoberta da penicilina redefiniu a longevidade humana. Hoje, a odontologia de alto padrão exige mais do que a erradicação da doença; exige a preservação do equilíbrio biológico.

METODOLOGIA DA REVISÃO

- Análise de 22 fontes literárias de alto impacto (2001–2023).
- Diretrizes globais da American Heart Association (AHA) e OMS.
- Foco na transição do uso empírico para a precisão baseada em evidências.

O LEGADO E A ADAPTAÇÃO

1928

A Revolução (Fleming e a Penicilina).

1940s

A Introdução Odontológica (Controle de infecções pós-cirúrgicas orais).

1961

A Padronização (Primeiras diretrizes da AHA para profilaxia).

SÉCULO XXI

A Ameaça Darwiniana (Cepas PRSP e a era das superbactérias).

*“O que sobrevive não é o mais forte, mas o que melhor se adapta.” —
O princípio de Darwin aplicado à resistência antimicrobiana.*

MECANISMOS DE AÇÃO E MODULAÇÃO

AÇÃO FARMACOLÓGICA

Interação com patógenos para morte (Bactericida) ou inibição reprodutiva (Bacteriostático).

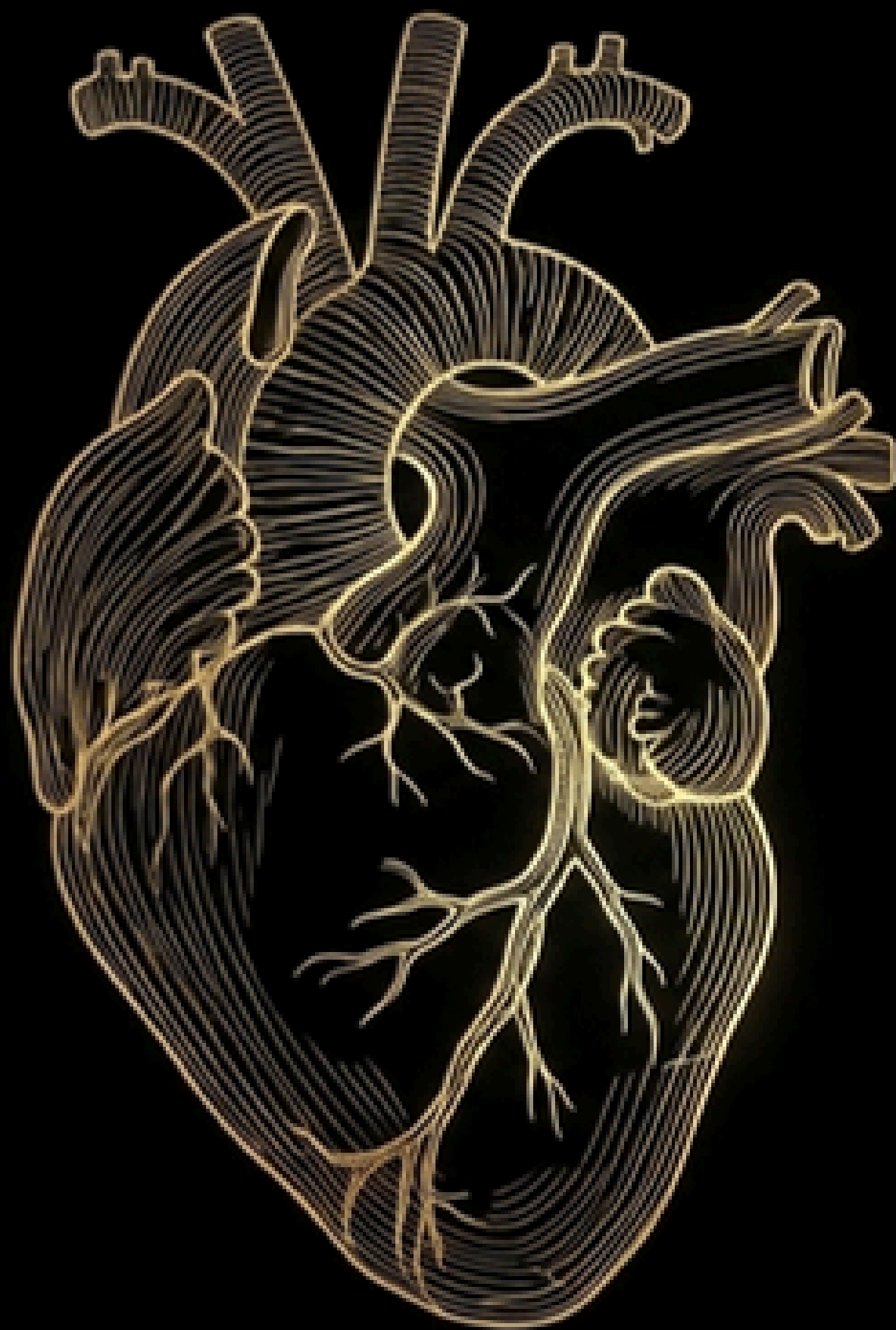
DECISÃO CLÍNICA:

Infeção controlada (sem sinais sistêmicos) exige apenas remoção da causa.

Infeção não controlada (trismo, celulite, febre) exige intervenção farmacológica.

MODULAÇÃO DO HOSPEDEIRO

O antibiótico não substitui a defesa celular; ele modula a carga bacteriana para permitir que o sistema imunológico assuma o controle.



O CORAÇÃO EM FOCO: ENDOCARDITE BACTERIANA

A bacteremia transitória pós-operatória representa um risco crítico para o endocárdio e valvas cardíacas previamente comprometidos. O principal agente: *Streptococcus viridans*.

- [X] Válvulas protéticas (ou transcateter)
- [X] Histórico prévio de Endocardite Infecçiosa
- [X] Cardiopatia congênita específica
- [X] Transplante cardíaco com valvulopatia

MATRIZ DE POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

DIABÉTICOS

Controle é a chave. Sem profilaxia se compensado. Profilaxia apenas em descompensação com sinais sistêmicos (cetoacidose/cetonúria).

IMUNOSSUPRIMIDOS

Decisão Estratégica. Profilaxia indicada para quimioterapia e transplante de medula. Não indicada como rotina para HIV ou leucemia não especificada.

PRÓTESES ORTOPÉDICAS

Conservadorismo. Não indicada rotineiramente. Não indicada rotineiramente. Exceções: primeiros 2 anos de prótese, desnutrição, hemofilia ou artrite reumatoide.

PACIENTES RENAIIS

Precisão Metabólica. Profilaxia apenas para pacientes em hemodiálise com risco cardíaco associado. Priorizar metabolização hepática.

PROTOCOLOS DE PRESCRIÇÃO: O PADRÃO-OURO

Administração única: 1 hora antes do procedimento cirúrgico.

AMOXICILINA

2g

(Adultos)

*A primeira linha de defesa
contra a bacteremia transitória.*

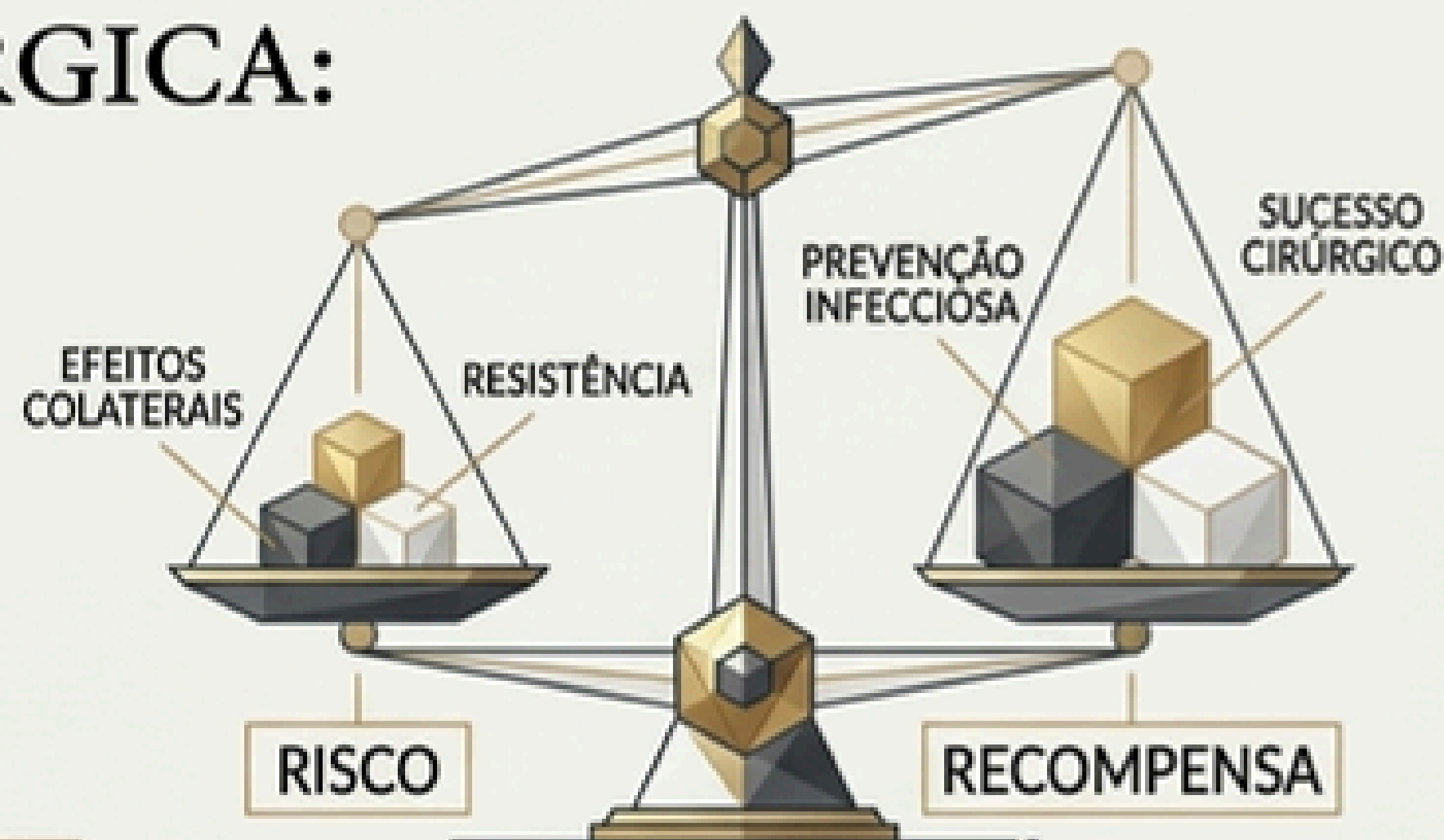
PACIENTES ALÉRGICOS
A PENICILINA:

- Cefalexina – 2g
- Azitromicina – 500mg

A eficácia da antibioticoterapia preventiva decai a zero se administrada 3 horas após o procedimento.

A CONTROVÉRSIA CIRÚRGICA: TERCEIROS MOLARES

A prescrição rotineira na exodontia de terceiros molares em pacientes saudáveis carece de forte base em evidências. A excelência cirúrgica substitui a muleta farmacológica.



4,6% a 10%

Índice de Infecção:
Prevalência natural
extremamente baixa.

> 30 minutos

Fator Tempo: Cirurgias
prolongadas elevam
exponencialmente o risco
infecioso.

~~Alveolite~~

Amoxicilina + Clavulanato reduz
riscos, porém não justifica o
uso empírico rotineiro devido
aos severos efeitos colaterais.

A PANDEMIA SILENCIOSA DA RESISTÊNCIA



10%

Dos antibióticos prescritos globalmente na área da saúde têm origem em consultórios odontológicos.

+49%

Aumento nas prescrições odontológicas durante a pandemia de COVID-19.

1.27 Milhão

Óbitos anuais globais diretamente causados pela resistência antimicrobiana.

Prescrever por "medo" ou sem respaldo é contribuir para o colapso da eficácia medicamentosa.

GOVERNANÇA CLÍNICA E LEGISLAÇÃO

A barreira contra a automedicação
e o uso indiscriminado.

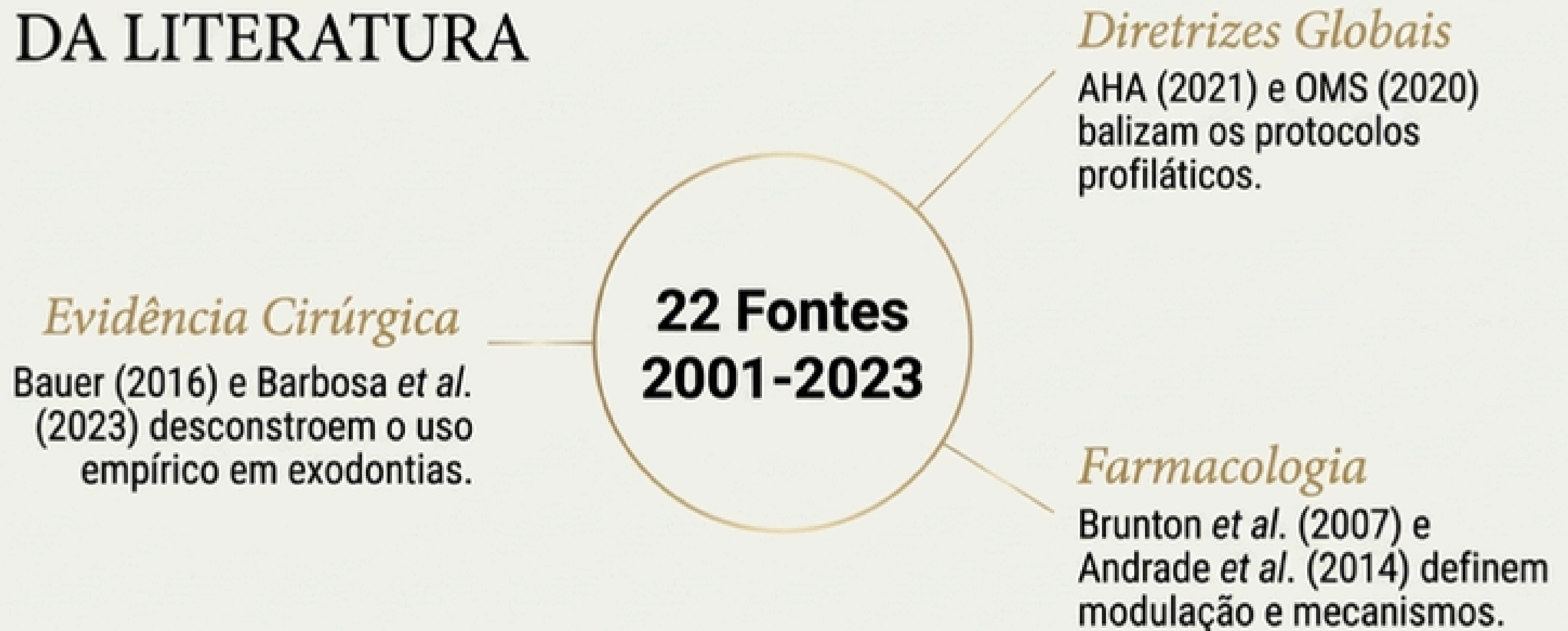
O Padrão ANVISA

RDC nº 44/2010.
Retenção de receita em via dupla.
Validade estrita de 10 dias.
O fim da prescrição informal.

A Visão Global da OMS

Plano de Ação Global (2015).
A conscientização ("Handle with Care")
e a educação continuada como a
primeira linha de salvaguarda.

ANÁLISE EVIDENCIÁRIA DA LITERATURA



A literatura é uníssona: a odontologia moderna migrou da cobertura antibiótica por precaução para a intervenção guiada pelo risco fisiológico.

A RELEVÂNCIA PARA O CLÍNICO EM ESTÉTICA

Na odontologia premium, a perfeição estética exige a integração magistral dos tecidos moles e duros.

- 1. Preservação do Microbioma:** O uso racional evita infecções fúngicas oportunistas que podem comprometer implantes e enxertos de alto valor.
- 2. Cicatrização Fisiológica:** A estética impecável requer tecidos saudáveis, não tecidos medicados.
- 3. Posicionamento de Autoridade:** O dentista premium não vende apenas sorrisos; entrega longevidade e segurança sistêmica.



A TRÍADE DA EXCELÊNCIA CLÍNICA



O domínio destas três esferas define o profissional que transcende a técnica e alcança a excelência integral.

A Ciência a Serviço da Exclusividade.

- ANDRADE, E. et al. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014.

- ANVISA. RDC nº 44, de 26 de outubro de 2010.

- BAUER, H.C. Associação entre o tempo cirúrgico e infecção pós-operatória na exodontia de terceiros molares. USP, 2016.

- BUONAVOGLIA, A. et al. Antibiotics or no antibiotics. Antibiotics, v.10, n.5, 2021.

- CONTALDO, M. et al. Antibiotics in Dentistry: A Narrative Review. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2023.

- CORDOVA, P. et al. Engaging the Global Dental Profession to Help Tackle Antibiotic Resistance. Medical Sciences Forum, 2023.

- DUARTE, A. et al. Quando realizar a profilaxia antibiótica em pacientes com alto risco para endocardite infecciosa? UNIUBE, 2017.

- OBEROI, S. et al. Antibiotics in dental practice: how justified are we. International Dental Journal, 2015.

- ROCHA, L. et al. Conhecimentos e condutas para a prevenção da endocardite infecciosa. Robrac, 2008.

- SANTOS, A. A relevância do uso racional dos antibióticos na odontologia. UNILAB, 2018.

- SILVEIRA, G. et al. Estratégias utilizadas no combate à resistência bacteriana. Química Nova, 2006.

- SOUZA, L.A.B.; COSTA JUNIOR, F.; PINTO, E.V. O uso racional dos antibióticos na odontologia. REASE, v.10, n.11, 2024.

- WILSON, W. et al. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis. Circulation, 2021.

- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Resistência antimicrobiana. 2023.

- ZAFALON, G. et al. Profilaxia antibiótica em pacientes portadores de diabetes mellitus insulino-dependentes. USJT, 2022.